Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5142485-02.2025.8.21.0001/RS

REQUERENTE: TÂNIA MARIA SOUZA DA ROSA

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

TÂNIA MARIA SOUZA DA ROSA ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **neoplasia maligna da mama (CID10-C50)** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Pembrolizumabe 200mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 17, DESPADEC1), bem como a gratuidade da justiça (evento 5, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 31, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 25, PET1).

A parte autora apresentou réplica (evento 35, PET1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 37, ATOORD1), nada requereram (evento 44, PET1; evento 48, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 51, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 17, DESPADEC1):

> *Segundo o **laudo médico** acostado aos autos (evento 1, LAUDO11), a parte autora apresenta o diagnóstico de neoplasia maligna da mama (CID10-C50), necessitando fazer uso do medicamento Pembrolizumabe 200mg associado ao esquema quimioterápico (já aprovado pelo convênio). Ressaltou a **urgência** do tratamento, pela **agressividade do carcinoma** e pelo **alto risco de recorrência sistêmica**:*
>
> *[...]*
>
> *A **nota técnica**, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao tratamento requerido, indicando que, apesar de não se enquadrar como emergência ou urgência, conforme definição do CFM, é **recomendado o início do tratamento com a maior brevidade possível** (evento 15, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a **negativa administrativa** do IPÊ-SAÚDE (evento 1, OUT12).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPÊ-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*

Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

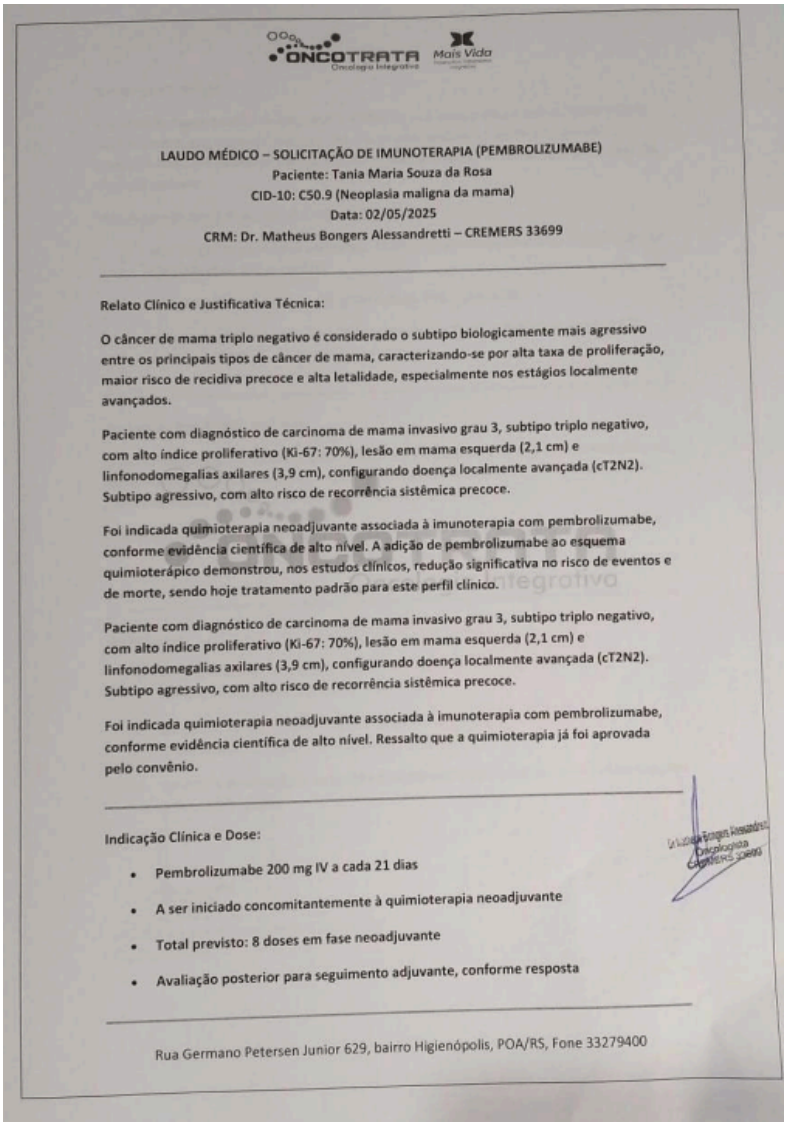
Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPÊ-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Pembrolizumabe 200mg**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (vento 1, LAUDO11), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **neoplasia maligna da mama (CID10-C50)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Pembrolizumabe 200mg**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento. Senão vejamos:



ONCOTRATA Oncologia Integrativa — Mais Vida

LAUDO MÉDICO – SOLICITAÇÃO DE IMUNOTERAPIA (PEMBROLIZUMABE)
Paciente: Tania Maria Souza da Rosa
CID-10: C50.9 (Neoplasia maligna da mama)
Data: 02/05/2025
CRM: Dr. Matheus Bongers Alessandretti – CREMERS 33699

Relato Clínico e Justificativa Técnica:

O câncer de mama triplo negativo é considerado o subtipo biologicamente mais agressivo entre os principais tipos de câncer de mama, caracterizando-se por alta taxa de proliferação, maior risco de recidiva precoce e alta letalidade, especialmente nos estágios localmente avançados.

Paciente com diagnóstico de carcinoma de mama invasivo grau 3, subtipo triplo negativo, com alto índice proliferativo (Ki-67: 70%), lesão em mama esquerda (2,1 cm) e linfonodomegalias axilares (3,9 cm), configurando doença localmente avançada (cT2N2). Subtipo agressivo, com alto risco de recorrência sistêmica precoce.

Foi indicada quimioterapia neoadjuvante associada à imunoterapia com pembrolizumabe, conforme evidência científica de alto nível. A adição de pembrolizumabe ao esquema quimioterápico demonstrou, nos estudos clínicos, redução significativa no risco de eventos e de morte, sendo hoje tratamento padrão para este perfil clínico.

Paciente com diagnóstico de carcinoma de mama invasivo grau 3, subtipo triplo negativo, com alto índice proliferativo (Ki-67: 70%), lesão em mama esquerda (2,1 cm) e linfonodomegalias axilares (3,9 cm), configurando doença localmente avançada (cT2N2). Subtipo agressivo, com alto risco de recorrência sistêmica precoce.

Foi indicada quimioterapia neoadjuvante associada à imunoterapia com pembrolizumabe, conforme evidência científica de alto nível. Ressalto que a quimioterapia já foi aprovada pelo convênio.

Indicação Clínica e Dose:

- Pembrolizumabe 200 mg IV a cada 21 dias
- A ser iniciado concomitantemente à quimioterapia neoadjuvante
- Total previsto: 8 doses em fase neoadjuvante
- Avaliação posterior para seguimento adjuvante, conforme resposta

Rua Germano Petersen Junior 629, bairro Higienópolis, POA/RS, Fone 33279400

ONCOTRATA Oncologia Integrativa — Mais Vida

Evidência Científica:

A indicação segue o protocolo do estudo KEYNOTE-522, ensaio clínico fase III, randomizado, multicêntrico, que avaliou o uso de pembrolizumabe associado à quimioterapia na neoadjuvância em pacientes com câncer de mama triplo negativo em estágio inicial com alto risco de recidiva.

Resultados (Schmid et al., *NEJM* 2020 e 2022):

- **pCR (resposta patológica completa): 64,8% com pembrolizumabe vs. 51,2% no grupo controle (Δ 13,6%; p < 0,001)**
- **Sobrevida livre de eventos (EFS): HR 0,63 (IC 95%: 0,48–0,82)**
- **Sobrevida global aos 60 meses foi de 86,6 *versus* 71,7% (HR=0,66; IC de 95%: 0,5-0,87; p=0,0015),**

Aprovação Regulatória no Brasil:

O pembrolizumabe foi aprovado pela ANVISA em 29/11/2021 para uso em combinação com quimioterapia na neoadjuvância, seguido de monoterapia adjuvante, para pacientes com câncer de mama triplo negativo com alto risco de recorrência.

Fonte: Bula aprovada de Keytruda® (MSD Brasil), conforme publicado no portal da ANVISA.

ONCOTRATA Oncologia Integrativa

Referências:

1. **Schmid P, Cortes J, Pusztai L, et al. *Pembrolizumab for early triple-negative breast cancer. N Engl J Med.* 2020;382(9):810–821.**
2. **Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. *Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med.* 2022;386:556–567.**
3. **ANVISA – Aprovação de indicação de Keytruda® para câncer de mama triplo negativo DOU 29/11/2021.**

Matheus Bongers Alessandretti CREMERS 33699
Oncologista clínico

Rua Germano Petersen Junior 629, bairro Higienópolis, POA/RS, Fone 33279400

ONCOTRATA Oncologia Integrativa — Mais Vida

Prescrição:

Tania Maria Souza da Rosa

02/05/25

Pembrolizumabe (Keytruda®) 200 mg
- Via intravenosa (IV)
- Administrar a cada 21 dias
- Total de 8 aplicações na fase neoadjuvante e 17 na adjuvante
- Avaliar continuidade em fase adjuvante conforme resposta

ONCOTRATA Oncologia Integrativa

gov.br Documento assinado digitalmente MATHEUS BONGERS ALESSANDRETTI Data: 02/05/2025 10:19:27-0300 verifique em https://validar.iti.gov.br

Rua Germano Petersen Junior 629, bairro Higienópolis, POA/RS, Fone 33279400

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53). ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do(s) medicamento(s) postulado(s) ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por TÂNIA MARIA SOUZA DA ROSA em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Pembrolizumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo médico assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 01/09/2025, às 18:39:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090006881v5** e o código CRC **e63dcd13**.